

QCM MPR

Q1 : lombalgies, encore et toujours... si drapeaux rouges faire un CT scan.

Q2 : Femme de 45 ans, fatigue depuis env 1 an, s'aggrave, dure du matin jusqu'au soir, manque d'énergie pour ses activités habituelles mais n'est pas triste, pas de trouble du sommeil. Appétit est conservé et poids stable. Menstruations régulières. Elle n'a pas d'autre plainte ni d'atcd médical notable. Ne fume pas, conso rarement de l'OH et jamais drogue. Depuis quelques années, alimentation essentiellement d'origine végétale. Mariée, 2 enfants de 15 et 12 ans. Juriste dans l'administration publique.

T 36.3, 96 bpm, 115/70, BMI 26, peau normale sans ictère, 3 gg cervicaux postérieurs indolores de 0.5 cm, autres aires gg sp. Thyroïde sp. Examen cardio-vasculaire, pulmonaire et abdo normal. Diagn le plus probable :

R : Anémie ferriprive

DD de la fatigue :

- Trouble dépressif, trouble anxieux
- Anémie ferriprive ou carence en fer sans anémie
- Insuffisance cardiaque
- Abus d'OH
- Hypothyroïdie
- Apnées du sommeil
- Sy de fatigue chronique (0.9%)

Q3 : 32 ans, brulures mictionnelles avec pollakiurie depuis 3j et fièvre 38.2, douleur lombaire G, pas de prurit vulvaire, 3 épisodes similaires au cours des 5 dernières années.

Examen clinique : afébrile, normocarde, normotendue, abdomen sensible dans la région sus-pubienne, loges rénales souples, G modérément douloureuse, D indolore. Bandelette montre leucocyturie 3+, traces de sang, pas de nitrites. PEC ?

R : Culture d'urine & ciprofloxacine 2x 500mg/j durant 7 jours

Infection urinaire haute :

- Douleur loge rénale et/ou fièvre
- EC : bandelette urinaire et culture d'urine avec ATBgramme
- Bactériurie sign si $> 10^5$ ou 10^3 avec uropathogène (chez patient sympto)

Q4 : 40ans, EF, rhinorrhée, mal de gorge depuis 3j, forte toux depuis 24h, gênant le sommeil. N'a pas mesuré de sa température, ce matin céphalées frontales et va pas au travail. Pas d'odynophagie.

Examen clinique : 37.8, fond de gorge érythémateux sans exsudat, écoulement post. Petits gg cervicaux ant (< 0.5 cm), indolore à la palpation. Douleurs à la percussion des sinus frontaux ddc. Tympan sp, Auscultation pulm sp. Diagn ?

R : IVRS

- Aspécifique
- Pharyngite aiguë
- Rhino-sinusite

Q5 : 58 ans, BPCO avec sy obstructif non réversible modéré (VEMS 65%), consulte car dyspnée progresse sous traitement d'anticholinergique inhalé. Fume depuis l'âge de 14 ans, consomme

30cig/j, envisage l'arrêt du tabac si vous pouvez l'aider avec un tt efficace. Dépendance à l'OH qu'il aimerait aussi réduire.

R : Approche motivationnelle car l'arrêt du tabac permet de réduire la progression de la maladie

Sevrage tabac :

- Approche motivationnelle
- CI des substituts nicotiniques : dans les 2 semaines après un infarctus
- Pharmaco :
 - o Champix (n'est plus disponible à Genève)
 - o Bupropion
 - o Vapotage

Q6 : 42 ans, épisodes occasionnels de vertiges sévères avec N/V, acouphènes, sensation d'oreille pleine. 1^{er} épisode date de 3 ans, depuis lors elle a eu 6 épisodes durant chacun entre 6h à 1-2j. Elle n'a pas de symptôme actuellement. Elle ne prend aucun traitement mais doit souvent rester au lit et manquer 1-2 j de travail durant ces épisodes. Anamnèse familiale de migraine.

Examen physique : signes vitaux normaux, pas de nystagmus, pas de déficit auditif, épreuves de Rinné-Weber normales. IRM cérébral normal.

R : Maladie de Ménière

Vertiges :

- Périphériques
 - o VPPB : bref, déclenché par changement de position, intermittent. Manœuvre de Hallpike, TT par manœuvre de Semont ou Epley.
 - o Neuronite vestibulaire : vertige **constant** durant plrs jours, N/V +++, nystagmus spontané qui bat du côté sain, se résout spon.
 - o Ménière : qq minutes/heures -jours, hypoacousie unilat, acouphènes, N/V, nystagmus spontané
 - o Neurinome VIII : hypoacousie, acouphènes... Dx par IRM
- Central

Q7 : 47 ans, bilan de santé. Aucune plainte, inquiète d'avoir un pb cardiaque car IM chez son frère de 42 ans. Arrêt tabac il y a un an, boit de l'OH occasionnellement, pas de drogue, alimentation équilibrée, pas d'AP régulière, activité sexuelle avec partenaire habituel sans protection.

Examen clinique sp.

R : Dosage sanguin du cholestérol tot et HDL

Q8 : 67 ans, maladie coronarienne, HTA, dyslipidémie. Depuis 1 an, il a des difficultés à avoir une érection, vie de couple heureuse, profite de sa retraite, pas déprimé ni anxieux.

Médication : metformine, tamsulosine, simvastatine, lisinopril, métoprolol, aspirine et NO sublinguale.

Examen clinique : 64 bpm, TA 126/76, examen uro-génital montre une prostate agrandie, lisse, symétrique, sans nodule. Testicules de taille et consistance normales. Pénis normal sans plaques fibreuses. Traitement ?

R : Alprostadil intra-caverneux (car sildénafil CI, prescription complexe qui se fait chez l'urologue)

Dysfonction érectile : fréquent, augmente avec l'âge, surtout chez patient qui ont des FRCV. FR : tabac, abus d'OH, opiacés, obésité, médicaments.

En premier : conseil psycho-social & changement des facteurs de risque

TT choix : inhibiteurs PDE-5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil), CI si prise de nitrés car ca fait des grosses hypotensions.

DD

- Artériopathie : début progressif, pas d'érections nocturnes, libido N. Doppler pénien anormal. Inhibiteur PDE-5, prostaglandine E1 intra-urétral/intra-caverneux, pompe à vie prothèse
- Neuropathie
- Hypogonadisme
- Médicaments : psychotropes, anti-hypertenseur (bêta-bloqueur)
- Trauma : chir, radiothérapie, trauma pelvien
- Psychogène

Q9 : 28 ans, T élevée, frissons, céphalées, diarrhée depuis 3j puis constipation opiniâtre 10j après son retour d'Inde. Consulte au 3^e jour des symptômes. N'a fait aucun vaccin avant le départ.

Examen physique : T 39.3, 72 bpm, TA 120/70, peau normale sans lésion, pas d'ADP, abdomen diffusément sensible, sans péritonisme, pas d'HSM, rate non palpable, bruits intestinaux normaux. Labo : Hb 135g/l, Leuco 5.2 G, Thrombocytes 250G/l, CRP 98. Diagnostic :

R : Fièvre typhoïde

- Amibiase
- Paludisme
- Leptospirose
- Fièvre typhoïde
- Grippe à Influenza

Mais il faudra faire un examen pour exclure le palu aux urgences.

Fièvre au retour de voyage, dépend de :

- Prévalence des maladies dans le lieu du voyageur
- Durée du séjour, temps d'incubation

Approche clinique :

- Recherche les patho aiguës et dangereuses : paludisme, fièvre typhoïde, rickettsiose, abcès amibien du foie, méningo-encéphalite, trypanosomiase africaine
- Infections cosmopolites : grippe, infections ORL, pulmonaires, urinaires

Fièvre typhoïde

- Entérobactérie : salmonella typhi
- Fréquent en Asie du Sud (Inde et Népal)
- Dissociation pouls-température, fièvre en plateau, douleurs abdo, constipation ou diarrhée, toux
- Examens complémentaires : hémoch
- TT : Cipro pendant 14j en attendant les hémocultures
- Prévention : vaccin (efficacité 60-70%)

Q10 : 64 ans, bilen préopératoire avant PTG D dans le cadre d'une arthrose invalidante.

Antécédant : IM avec angioplastie & 2 stents il y a 4 ans, diabète type 2, HTA, pas de douleurs thoraciques, pas de dyspnée, peut monter 2 étages sans symptôme, marche limitée à 200m à cause des dlrs du genou. TT : aspirine, métoprolol, lisinopril, atorvastatine, metformine et empagliflozine. TA 140/80, 60 bpm, BMI 30. Auscultation cardio-pulmonaire N. Pas de TJ ni œdème. Créatinine 102, Na 138, K 4.1, HbA1 6.9%. ECG : ondes Q en D2, D3 et aVF, anomalies ST-T aspécifiques, signes HVG. Rx thorax normal. PEC ?

R : Aucune investigation supplémentaire

Bilan cardio pré-op : 4 MET c'est un effort plutôt faible. Ici le patient est > 4MET car grimpe les escaliers sans symptômes. S'il s'était plaint de symptômes, on pourrait faire une écho de stress ?

Médicaments :

- Poursuivre
- Arrêter : AINS, metformine, oestrogènes, diurétiques, insuline (stop rapide, diminuer lente)

Aspirine peut être maintenue dans le cas d'une chir mineur, stop 7-10j avt chir majeure.

Q11 : 42 ans, douleurs épigastriques après les repas, augmentant en intensité depuis 2 semaines. Pas de perte de poids, pas de vomissement, pas de dysphagie, pas d'hématémèse ni méléna. Souvent des lombalgies, dont un épisode depuis 2 semaines traité par ibuprofène 3x 600mg/j. Aucune autre antcd.

Examen clinique : BEG, afébrile, 80 bpm, TA 128/78, peau bien colorée, sans ictère. Douleurs à la palpation de l'épigastre, sans défense ni détente ni murphy. Pas de masse abdo, bruits abdo normaux. TR normal.

R : arrêt de l'ibuprofène et ttt par IPP

Q12 : 41 ans, connue pour asthme traité par du salbutamol en R. Consulte car elle a depuis 1 semaine, une toux sèche, une dyspnée d'effort quotidienne et une dyspnée 1 nuit sur 2.

Examen : afébrile, TA 105/70, FC 60/min, FR 12/min. Sibilances expiratoires diffuses. PF 80% du prédit. SaO2 99%. Traitement ?

R : CSI + beta agoniste de longue durée d'action

- Hospitalisation en urgence
- Beta 2 agoniste à courte durée d'action
- Cortico inhalé
- Prednisone 0.5mg/kg PO durant 4 semaines
- CSI + beta agoniste à longue durée d'action

+ à revoir dans les 3-4j, éducation thérapeutique pour qu'elle mesure son peak flow.

Photo du schéma step-up.

Q13 : 55 ans, suivi de son HTA traitée par inhibiteur d'enzyme de conversion, diurétique thiazidique et anti-calcique. Malgré ce traitement, TA pas contrôlée, avec moyenne 164/104. Fume depuis 40 ans avec 20cig/j.

BMI 24.8, TA 180/114, artères toutes palpables sans souffle, examen du FO montre une rétinopathie hypertensive stade 2. Reste de l'examen sp.

Labo normal sauf kaliémie 2.8.

R : Dosage de la rénine et de l'aldo plasmatique après interruption de l'IEC et diurétique

- Dosage immédiat du potassium dans les urines de 24h
- Dosage du cortisol urinaire sur 24h
- Dosage des métanéphrines urinaires
- Dosage de la rénine et de l'aldostérone plasmatique après interruption de l'IEC et diurétique
- IRM avec angiographie des a. rénales

HTA secondaires :

- Rénale parenchymateuse
- Rénal-vasculaire : à rechercher si HTA sévère ou réfractaire, augmentation de la créatininémie sous IECa ou sartan, athéromatose diffuse. Investigation : IRM + angiographie, CT + angiographie, US-doppler)
- Hyper-aldostéronémie primaire : à rechercher si HTA sévère ou réfractaire, kaliémie < 3.5 (<3 sous diurétiques). Investigations : dosage de l'aldo et activité de rénine (interruption des diurétiques, IEC, sartan).
- Phéochromocytome
- Sy de Cushing

Q14 : 75 ans, consulte pour suivi trimestriel. Connu pour DM2 traité par metformine, HTA traité par lisinopril + HCTZ, dyslipidémie traitée par atorvastatine, BPCO stade modéré traité par tiotropium. Depuis 3 mois, HTA est mal contrôlée (160-170/90/110), patient dit prendre son tt correctement à l'aide de son pilulier.

Examen : BMI 29, TA 162/108, auscultation cardio-pulmonaire normale, pas de TJ ni d'œdèmes. FO montre rétinopathie hypertensive stade 2. Reste de l'examen clinique sp. On décide de majorer son tt hypertenseur, comment ?

R : Ajouter un anti-calcique

- Bloqueur du système RAA
- Ajouter un Beta bloquant
- Ajouter un Anti-calcique (mais chez la personne âgée on peut parfois éviter car risque de chute sur hypotension orthostatique. D'ailleurs on peut faire un test de Schellong quelques jours après introduction d'un anti-calcique chez pers âgée).
- Ajouter un inhibiteur de la rénine

Recommandation actuelle c'est bithérapie d'emblée : IECa + diurétiques

Pas toujours de lien dose-effet

Q15 : 55 ans, DM2, BMI 28, HTA, consulte suivi trimestriel. Traité par lisinopril 20 avec tt par régime et AP, diabète était bien contrôlé avec HbA1c 6.2% jusqu'à 4 mois. Poids stable et alimentation n'a pas changé. Depuis 3 mois son diabète est moins bien contrôlé avec glycémies sup à 10 et HbA1c 8.9%. Traitement : R = E.

- Motiver à perdre du poids et faire + d'AP
- Insuline intermédiaire matin et soir
- Inhibiteur de SGLT2
- Gliptine
- Metformine + inhibiteur de SGLT2 ou agoniste GLP-1

Recommandations actuelles (photo) : introduire d'emblée une bithérapie, Metformine + un 2^e médicament en fonction du profil du patient :

- SGLT2 si IC ou IR
- GLP-1 : surpoids (BMI min 28)

On peut aussi associer ces 3 classes mais assurance ne veut pas rembourser.